

المرجع الوظيفي والتشغيلي الموحد

نظام تصنيف وفرز الأطباء

والنظام المالي المرتبط به

مرجع نهائي لفريق تصميم وبرمجة منصة UberTib

التصنيف العلمي بحسب المجال | الفئة السعرية | مستوى الحماية | التقييم الاجتماعي | دورة المعاملة والدفتر المالي

الإصدار المرجعي 2.0

5 آب/أغسطس 2026

المحتويات التنفيذية

الجزء	الموضوعات
أ	القرارات الحاكمة، مؤشرات الطبيب، المجالات العلاجية، وقاموس الخدمات.
ب	محرك التصنيف العلمي، الثقة، التجهيزات، التقييم الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي.
ج	الفئة السعرية، الحماية، العمولات، المخاطر، المعاملات، التسويات، وصندوق الحماية.
د	لوحات المستخدمين، نموذج البيانات، الحالات البرمجية، الصلاحيات، والتقارير.
هـ	معايير القبول، خطة الإطلاق، الإعدادات الافتراضية، والمصطلحات.

الملخص التنفيذي

يبنى UberTib منظومة واحدة تربط الأهلية السريرية والسمعة الموثقة والتسعير والحماية المالية. لا يحمل الطبيب «رتبة واحدة»؛ بل يحمل تصنيفاً علمياً مستقلاً في كل مجال علاجي وفي كل منشأة، ويستطيع اختيار فئة سعرية مساوية أو أدنى، ثم اختيار مستوى حماية مسموح. ويظهر تقييم المرضى منفصلاً بالنجوم.

- الفئات العلمية المعتمدة خمس فقط: A و B و C و D و F. تلغى E من جميع الواجهات والقواعد والجداول.
- المجالات الظاهرة في الإصدار الأول أربعة فقط، بينما يبقى قاموس الخدمات الداخلي مفصلاً وقابلاً للتوسع.
- التقويم خارج MVP، ولا يندرج ضمن طب الأسنان العام.
- العمولة تتبع الفئة السعرية، ومساهمة صندوق الحماية وسقفها يتبعان مستوى الحماية، ومعامل المخاطر الفردي يضيف زيادة مؤقتة عند الحاجة.
- كل قيمة مالية أو حد تصنيفي أو إعفاء يُدار من سياسة إصدارية، ولا يثبت داخل الكود.
- تُحفظ لحظة كاملة لشروط كل خطة عند قبولها؛ فلا تتغير المعاملة المدفوعة بأثر رجعي.
- الذكاء الاصطناعي يفرز ويحلل ويفسر، لكنه لا يشخص ولا ينفرد بقرار جوهري يمس السمعة أو المال أو العلاج.

النموذج الحاكم: S العلمي يحدد أهلية الخدمة؛ P التجاري يحدد نطاق السعر وعمولة المنصة؛ H يحدد مساهمة صندوق الحماية وسقف حماية المريض؛ I يحدد زيادة المخاطر وفترات الاحتجاز؛ R الاجتماعي يعبر عن تجربة المريض فقط.

الجزء الأول

نموذج المنتج والتصنيف العلمي

1. القرارات الحاكمة المعتمدة

القرار	القاعدة التنفيذية	الأثر البرمجي
عدد الفئات	A و B و C و D و F فقط؛ لا يوجد E.	Enum من خمس قيم + حالة مستقلة «قيد التقييم».
وحدة التصنيف	الطبيب x المجال x المنشأة/الفرع x فترة القياس.	لا توجد درجة عامة مشتقة من متوسط المجالات.
المؤشرات الظاهرة	علمي + سعري + حماية + تقييم اجتماعي.	حقول مستقلة وفلاتر مركبة.
التقويم	مستبعد من MVP.	Feature flag مغلق، ولا يظهر ضمن العام.
الأشعة	رقمي: بلا سقف؛ تقليدي: سقف D؛ لا جهاز: F.	بوابة منشأة قابلة للإصدار والمراجعة.
المراجعة	كل 90 يوماً مع مراقبة مستمرة.	Snapshot ربع سنوي وأحداث مراجعة عاجلة.
الإطلاق	تشغيل تجاري حقيقي مع معايير حية 90 يوماً.	وسم «تصنيف أولي» ومراجعة بشرية موسعة.
السياسة	تعديل مستقبلي للحجوزات الجديدة فقط.	Policy version + effective date + immutable snapshot.

2. المؤشرات المستقلة لكل طبيب

المؤشر	الرمز	من يحدده؟	ماذا يتحكم؟	ما يظهر للمريض؟
التصنيف العلمي	S	محرك علمي + مراجعة بشرية	أهلية المجال والخدمة والسقف السريري	A/B/C/D/F في المجال، الثقة، الحالات، تاريخ التحديث
الفئة السعرية	P	الطبيب ضمن الحد المسموح	نطاق السعر وعمولة المنصة	الفئة السعرية المختارة
مستوى الحماية	H	الطبيب ضمن S و P والسياسة	المساهمة وسقف حماية المريض	المستوى والنسبة القصوى
التقييم الاجتماعي	R	مرضى متوقعون بعد التحقق	الفرز وتجربة الخدمة؛ لا يغير S	نجوم مصححة وعدد تقييمات
مخاطر الطبيب	I	النظام + مراجعة عند الارتفاع	زيادة مساهمة الحماية والاحتجاز	لا يظهر رقمه الخام؛ تظهر آثار السياسة بوضوح

مثال واجهة: التصنيف العلمي في الزراعة: A | الفئة السعرية: C | مستوى الحماية: A حتى 100% | تقييم المرضى: 5/4.7 من 62 معاملة موثقة.

3. المجالات العلاجية للإصدار الأول

الكود	المجال الظاهر	الخدمات الأساسية المشمولة	ملاحظات التشغيل
G01	الجراحة واللثة وزراعة الأسنان	القلع، أضرار العقل، الجراحة الصغرى، علاج وجراحة اللثة، الزراعة، ترقيع العظم، رفع الجيب، المضاعفات.	تصنيف مستقل؛ تتعدد مستويات الخطر والخدمات الفرعية.
G02	التركيبات الثابتة والتجميل وابتسامة هوليود	التيجان، الجسور، الفينير، التركيبات فوق الزرعات، إعادة التأهيل، تصميم الابتسامة، التجميل المباشر وغير المباشر.	التبييض يمكن ضبطه ضمن G04 أو هنا وفق بطاقة الخدمة.
G03	علاج الجذور وسحب العصب	العلاج الأولي، إعادة العلاج، الأدوات المكسورة، الثقوب، المضاعفات، الجراحة الذروية.	يتطلب توثيقاً شعاعياً مبرراً وبروتوكولات خاصة.
G04	طب الأسنان العام	الفحص والتشخيص والوقاية، الحشوات، التنظيف، التبييض، الأطفال، الأطقم المتحركة، الإسعافات والخدمات الأخرى.	لا يتضمن التقويم، ولا يدمج خدمات المجالات الثلاثة الأخرى.

قرار MVP: يُستبعد تقويم الأسنان كلياً من الإصدار الأول، ويُحجز له مجال مستقل مستقبلياً بعد اعتماد معايير نتائج ومتابعة وضمان وتسويات ثلاث العلاج طويل الأجل.

4. قاموس الخدمات وبطاقة الخدمة

يرى المريض أربعة مجالات بسيطة، بينما يعتمد المحرك قاموساً داخلياً تفصيلياً. كل خدمة سجل مستقل قابل للإصدار؛ فلا تُعامل الحشوة والتنظيف والزراعة والخدمة الجراحية بقواعد واحدة.

مجموعة الحقول	الحقول الإلزامية
الهوية	service_id، الاسم العربي، المجال، المجال الثانوي، حالة التنفيل.
الأهلية	الحد الأدنى العلمي، إذن الإجراء، المؤهل، الخبرة، اعتماد المنشأة.
الخطر	R0-R3، مضاعفات متوقعة، شروط الإحالة، معايير الإيقاف.
التوثيق	قبل/أثناء/بعد، الصور والأشعة المبررة، الموافقة، المواد، الطوابع الزمنية.
المتابعة	نقاط زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة، تعريف إغلاق الحالة.

5. البنية متعددة الطبقات وبوابات الأهلية

قاعدة الحجز: القرار الفعلي هو الأدنى بين تصنيف الطبيب في المجال، وإذن الخدمة، واعتماد المنشأة، والحالة الرقابية. لا تنتقل جاهزية فرع إلى فرع آخر.

صفحة 5

الوحدة	أهم البيانات	التحقق
الأجهزة	نوع، رقمي/تقليدي، رقم، صيانة، معايرة، ترخيص.	مستندات واختبار وتدقيق دوري.
السلامة	تعقيم، مؤشرات، PPE، نفايات، مياه، تدريب.	قوائم وسجلات وتدقيق مفاجئ.
الخدمات والأسعار	خدمات مطلوبة، P، H، سعر ومدة ومواد.	مطابقة القاموس والنطاق والسياسة.
الحالات	تشخيص، خطورة، أدلة، نتيجة، متابعة، شكوى.	الحالات داخل المنصة تلقائية وغير قابلة للحذف.
الإفصاحات	مضاعفات، إحالات، تضارب، دفع خارجي.	مطابقة مع المرضى والمدفوعات.

7. محرك التصنيف العلمي

يحسب المحرك درجة أداء S من 100 لكل مجال ومنشأة. التجهيز المطلوب بوابة أهلية، وليس طريقاً لشراء النقاط؛ وتبقى تجربة المريض الاجتماعية خارج الدرجة العلمية.

المحور	الوزن	ما يقيسه
النتائج المعدلة بالمخاطر	30%	النجاح والاستقرار وإعادة العلاج والمضاعفات مقارنة بصعوبة الحالة.
التوثيق السريري	20%	اكتمال وأصالة وتوقيت السجل والصور والأشعة المبررة.
السلامة ومكافحة العدوى	15%	التعقيم والبيئة السريرية والاستخدام الآمن.
المؤهلات والخبرة	15%	تعليم وتدريب مرتبطان بالمجال وخبرة مثبتة.
البروتوكول وإدارة المضاعفات	10%	الخطة والموافقة والإفصاح والإحالة والمتابعة.
النزاهة التشغيلية والمالية	5%	الأسعار، الدفع داخل المنصة، عدم الانتقاء أو التحايل.
التعلم والتحسين	5%	خطط التصحيح، التعلم الحديث، وإغلاق فجوات الجودة.

معادلة النقاط: $S = 0.30O + 0.20D + 0.15S_s + 0.15Q + 0.10P_r + 0.05I_n + 0.05L$. كل مكون من 0 إلى 100، ولا تصبح فئة النقاط هي الفئة النهائية قبل تطبيق الثقة والبوابات.

8. هرم المؤهلات ومصدر الشهادة

المستوى	نوع الدليل	نطاق محاور المؤهلات	متطلبات التحقق
T1	اختصاص رسمي/إقامة/بورد مرتبط بالمجال	100-90	تحقق مباشر من المصدر والجهة المهنية.

المستوى	نوع الدليل	نطاق محاور المؤهلات	متطلبات التحقق
T2	ماجستير أو دبلوم عالٍ بتدريب سريري وتقييم	89-75	الجامعة والمنهج والمدة والحالات والامتحان.
T3	برنامج مهني منظم بإشراف وحالات وامتحان	74-55	الساعات والمشرفون والتقييم.
T4	تعليم مستمر تطبيقي مع اختبار	54-30	المحتوى والساعات والنتيجة.
T5	حضور قصير أو شهادة تجارية بلا تقييم سريري	29-5	إثبات حضور فقط؛ لا يعامل كاختصاص.
T6	ادعاء أو وثيقة غير قابلة للتحقق	0	لا تستخدم وقد تفتح تحقيقاً عند التضليل.

9. كفاية الأدلة والثقة

تفصل المنصة بين جودة الأداء وقوة الدليل. الطبيب قليل البيانات لا يوصف بالفشل؛ يظهر «قيد التقييم» حتى يحقق حد الثقة، بينما لا تُمنح A أو B بالشهادات وحدها.

المستوى	حد K	وحدات الدليل EU	السقف	العرض
C0	50 > أو شرط ناقص	5 >	لا حرف	قيد التقييم - أدلة محدودة
C1	50 ≤	11.99-5	D	ثقة أولية
C2	60 ≤	24.99-12	C	ثقة متوسطة
C3	75 ≤	44.99-25	B	ثقة قوية
C4	85 ≤	20 + 45 ≤ حالة فريدة	A	ثقة مرتفعة

- $K = 0.05A + 0.10R + 0.15T + 0.20M + 0.25N + 0.25V$ ، وتمثل التحقق والحجم والنضج والتنوع واكتمال السجل ونتيجة التدقيق.
- $EU = \text{وزن دليل الخدمة} \times \text{اكتمال التوثيق} \times \text{نضج المتابعة} \times \text{موثوقية المصدر}$.
- أوزان الإطلاق المقترحة: $R0=0.25$ ، $R1=0.50$ ، $R2=0.75$ ، $R3=1.00$ ؛ لا ترفع الحالة الأخطر الثقة أسرع من وحدة واحدة.
- C0 حالة وليست فئة. يمكن السماح بخدمات R0/R1 محددة وفق سياسة تأهيل بشري وشروط مالية محافظة، دون نشر حرف.

10. الفئات العلمية الخمس

الفئة	نطاق S	الثقة	التعريف التشغيلي	النطاق العام
A	100-90	C4	أداء مرجعي موثق ونتائج ناضجة	R0-R3 ضمن الصلاحية
B	89.99-80	+C3	أداء متقدم ومستقر	R0-R3 ضمن الصلاحية
C	79.99-70	+C2	أداء معياري موثق	R0-R2؛ R3 بشروط
D	69.99-50	+C1	أداء نامٍ أو نطاق محافظ يحتاج تطويراً	R0-R1؛ R2 مختار
F	>50 أو بوابة F	+C1 عند فشل الأداء	لا يستوفي حالياً شروط المنصة في المجال/المنشأة	R0 وخدمات غير غازية مختارة بلا حماية

- A لأول مرة تحتاج اعتماداً بشرياً من مراجع مختص.
- F ليست مرادفاً لإيقاف الحساب ولا تعني «طبيباً فاشلاً»؛ يُحفظ سببها داخلياً: نتائج دون الحد، نقص جاهزية، أو نقص إذن إجراء.
- الترخيص غير الساري أو التزوير أو خطر السلامة الجسيم يؤدي إلى تعليق/رفض، لا إلى إبقاء الطبيب قابلاً للحجز تحت F.
- الفئة النهائية = الأدنى بين فئة S وسقف K/EU وسقف المنشأة والسلامة وصلاحية الخدمة.

11. شرط الأشعة والتجهيز والسلامة

وضع الأشعة الذروية داخل الفرع	أثره	متطلبات الإثبات
جهاز مناسب مع مستقبل/سير عمل رقمي	لا يفرض سقفاً تلقائياً؛ يستمر التصنيف بالأداء.	هوية الجهاز، الصيانة، الجودة، التدريب، الترخيص إن لزم.
جهاز تقليدي/فيلم أو غير رقمي	الحد الأعلى D في ذلك الفرع.	تعريف تقني دقيق، صلاحية، صيانة، توثيق الاستخدام.
لا يوجد جهاز أشعة ذروية داخل الفرع	F إلزامياً في ذلك الفرع.	لا يعوضه إرسال المريض إلى بانوراما أو CBCT.

تنبيه سريري وقانوني: هذه قاعدة أهلية تجارية للمنصة بطلب المالك، وليست حكماً طبياً عاماً. يجب تعريف «رقمي/تقليدي» واعتماد نطاق التطبيق من لجنة أكاديمية ومحام، ولا تُطلب صورة شعاعية إلا عند وجود مبرر سريري.

تظل مكافحة العدوى بوابة مستقلة غير قابلة للتعويض بنقاط مرتفعة. ويُقيّم الجهاز بملاءمته وصيانتته وسلامة استخدامه، لا بثمنه أو كثرة أجهزته.

12. التعيين الأولي ودورة إعادة التصنيف

1. يرفع الطبيب ملفه العام، ويطلب تفعيل مجال وخدمات وفروع محددة.
2. تُفحص البوابات القانونية والسلامة والأشعة واعتماد المنشأة.
3. تُتُحقق المؤهلات والحالات السابقة وتُحسب S و K و EU.
4. يصدر تصنيف أولي مسبب أو حالة «قيد التقييم»، مع حدود الخدمات.
5. تُراقب البيانات باستمرار، لكن يُقفل التصنيف الرسمي كل 90 يوماً.
6. تُراجع القرارات الجوهرية بشرياً، ثم يُفتح اعتراض مستقل قبل النشر النهائي.
7. يطبق التصنيف الجديد على الخطط الجديدة؛ وتبقى لقطعة المعاملات السابقة محفوظة.

الحركة	الشرط الافتراضي	المعالجة
ترقية	تجاوز الحد بنقطتين في دورتين + اكتمال الثقة	اعتماد بشري عند A أو أثر مالي كبير.
خفض عادي	الهبوط بنقطتين في دورتين	تنبيه وخطة تحسين واعتراض قبل النشر.
مراجعة عاجلة	هبوط $10 \leq$ ، حادث—ة حرجية، ترخيص/سلامة/تزوير	تجميد احترازي أو مراجعة فورية.
عودة بعد تعليق	خطة تصحيح + تحقق + فترة مراقبة	لا عودة آلية.

معايرة الإطلاق: لا توجد مرحلة ظل بلا مرضى. يبدأ تشغيل تجاري فعلي، وتُوسم التصنيفات خلال أول 90 يوماً بأنها «أولية/قيد المعايرة»، وتخضع القرارات المؤثرة لمراجعة بشرية موسعة.

13. نظام التقييم الاجتماعي والتحقق من المراجعات

التقييم الاجتماعي من 1 إلى 5 نجوم، مستقل تماماً عن التصنيف العلمي، ولا يقبل إلا من مريض مرتبط بحجز ودفع وخدمة فعلية داخل المنصة.

البعد	الوزن	السؤال القابل للملاحظة
التواصل	20%	هل شرح الطبيب والخطة بلغة مفهومة؟
الاحترام والخصوصية	15%	هل عومل المريض باحترام وحُفظت خصوصيته؟
وضوح التكلفة	20%	هل ظهر السعر والتغيير قبل الموافقة؟
الالتزام والانتظار	15%	هل التزم الموعد أو أبلغ المريض بالتأخير؟
النظافة المدركة	10%	هل بدت البيئة والأدوات منظمة ونظيفة؟
المتابعة والاستجابة	15%	هل استجاب الفريق بعد العلاج؟
الراحة والوصول	5%	هل كانت رحلة الوصول والحضور ميسرة؟

13.1 سير التحقق

1. ينشأ التقييم بحالة PENDING_VERIFICATION ولا يُنشر فوراً.
2. يتحقق النظام من الحجز والدفع والخدمة، ثم يرسل OTP إلى رقم المريض المحفوظ سراً.
3. خلال أول 6-12 شهراً، يتصل موظف مستقل بكل صاحب تقييم بأسئلة ثابتة قصيرة.
4. بعد التوسع، يصبح الاتصال إلزامياً للتقييمات السلبية والمعتراض عليها والمشبوهة، وعشوائياً لبقية التقييمات.
5. ينشر الرأي الحقيقي حتى لو كان سلبياً، ويرفض المزيف أو الكيدي أو المتعارض المصالح أو المحفز مالياً.
6. الادعاء السريري لا يحسمه موظف الهاتف؛ يُحال لمسار النزاع الطبي، ويمكن نشر جزء تجربة الخدمة بعد تنقيحه.

الحالة	المعنى	الانتقال
PENDING_VERIFICATION	قيد فحص المعاملة والهوية	OTP ثم مراجعة آلية/بشرية.
CALL_REQUIRED	يتطلب اتصالاً مستقلاً	اتصال موثق ومحاولات محددة.
PUBLISHED	تجربة حقيقية قابلة للنشر	تدخل المتوسط البايزي.
REJECTED	مزيف/كيدي/تعارض مصالح/تحفيز	سبب محفوظ وإمكانية مراجعة.
CLINICAL_ESCALATION	ادعاء يتعلق بالنتيجة الطبية	ملف نزاع طبي منفصل.
APPEALED	اعترض الطبيب	مراجعة بشرية ثانية مستقلة.

المتوسط المصحح: $Review^* = (v/(v+m)) \times R + (m/(v+m)) \times C$ ، والقيمة الابتدائية $m=20$. لا يظهر طبيب ذو مراجعتين أعلى تلقائياً من طبيب لديه سجل كبير.

14. حوكمة الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية

طبقة المحرك	الوظيفة	ما لا يجوز لها فعله منفردة
القواعد	فحص الترخيص والوثائق والبوابات والحدود.	تفسير قانوني أو استثناء غير موثق.
تحليل الوثائق	استخراج بيانات، نقص، تعارض، احتمالية أصالة.	اتهام تزوير نهائي.
جودة الصور	قابلية القراءة، اكتمال، تكرار، بيانات زمنية.	تشخيص المريض أو تقرير فشل علاجي نهائي.

طبقة المحرك	الوظيفة	ما لا يجوز لها فعله منفردة
التحليل الإحصائي	EU و K و S وتصحيح المخاطر والاتجاهات.	خفض جوهري بلا مراجعة واعتراض.
كشف الشذوذ	تقييمات متواطئة، صور مكررة، قفزات غير طبيعية.	إدانة الطبيب أو المريض.
محرك التفسير	أسباب ونواقص وخطة تحسين.	إخفاء العوامل المؤثرة أو إنتاج قرار غير قابل للإعادة.

- مراجعة بشرية إلزامية: ترقية A لأول مرة، خفض جوهري، F بسبب نتائج، تعليق، تعويض يتجاوز 10%، ثقة أقل من 85%، إعادة علاج/قلع، ضرر جسيم، اعتراض.
- يحفظ كل تشغيل: model_version و policy_version والمدخلات والدرجات والأسباب والمراجع والتاريخ.
- يُخفى اسم الطبيب والمنطقة عن تحليل الصور كلما أمكن لتقليل التحيز.
- لا تدخل شهرة الحي أو قيمته العقارية في التصنيف العلمي؛ الموقع للملاءمة والسعر والوصول فقط.

الجزء الثاني

النظام المالي والحماية ودورة المعاملة

15. النموذج المالي الجديد

التغيير الجوهري: يُلغى الاقتطاع الثابت 15% لجميع الفئات. يصبح صافي الطبيب متغيراً؛ العمولة حسب P، والحماية حسب H، وتضاف زيادة المخاطر I عند استحقاقها.

الفئة عند تطابق H و P	عمولة المنصة	مساهمة الحماية	الإجمالي الأساسي	صافي الطبيب	سقف الحماية
A	10%	5%	15%	85%	حتى 100%
B	8.5%	3.5%	12%	88%	حتى 70%
C	7%	2%	9%	91%	حتى 50%
D	5%	1%	6%	94%	حتى 30%
F	4%	0%	4%	96%	لا حماية

هذه نسب إطلاق في Policy Version مستقلة. لا تُعامل كحقوق دائمة، ولا تُكتب كثوابت داخل التطبيق أو قاعدة الأعمال.

16. اختيار الفئة السعرية ومستوى الحماية

التصنيف العلمي S	الفئات السعرية P المسموحة	مستويات الحماية H المسموحة
A	A أو B أو C أو D	من P صعوداً حتى A
B	B أو C أو D	من P صعوداً حتى B
C	C أو D	من P صعوداً حتى C
D	D فقط	D فقط
F	F فقط؛ لا اختيار طوعي	F فقط؛ بلا حماية
فيد التقييم	لا اختيار ذاتي	وفق سياسة تأهيل بشرية للخدمات المسموحة

- لا يستطيع الطبيب رفع P فوق S، ولا يستطيع اختيار F للهروب من العمولة أو الحماية.

- إذا كان $S=A$ و $P=C$ ، يمكنه اختيار $H=C$ أو B أو A ؛ تعرض الواجهة خيار C الافتراضي وخيار «الحماية الكاملة حسب التصنيف العلمي»، مع إمكان تفعيل الوسيطيات من لوحة الإدارة.
- العمولة دائماً حسب P ؛ مساهمة الحماية وسقفها دائماً حسب H ؛ أهلية العلاج حسب S وإذن الخدمة والمنشأة.
- أي تغيير في P أو H يسري على الخطط الجديدة فقط.

مثال	عمولة P	حماية H	إجمالي أساسي	صافي الطبيب قبل الرسوم
$S=A, P=C, H=C$	7%	2%	9%	91%
$S=A, P=C, H=B$	7%	3.5%	10.5%	89.5%
$S=A, P=C, H=A$	7%	5%	12%	88%

17. معادلات التخصيص المالي

الرمز	التعريف	المعادلة
G	قيمة المرحلة/الخدمة المقبوضة	المبلغ الفعلي المقبوض
Pc	عمولة المنصة	$G \times c(P)$
Gb	مساهمة الحماية الأساسية	$G \times g(H)$
Ra	زيادة المخاطر الفردية	$G \times r(I)$
Pf	رسوم بوابة الدفع	بحسب gateway_fee_payer في لقطة السياسة
Dt	ضرائب/استقطاعات الطبيب	بحسب القانون والسياسة
Dn	صافي استحقاق الطبيب	$G - Pc - Gb - Ra - Pf_doctor - Dt$
Cap	السقف النظري للحماية	القيمة المؤهلة $\times cap(H)$

التعويض الفعلي: الأقل من الخسارة المؤهلة، وسقف H ، وتكلفة إعادة العلاج/التصحيح المعتمدة، والحد المتبقي للخطأ. لا يمثل سقف الحماية سقفاً لمسؤولية الطبيب المهنية أو القانونية.

18. معامل المخاطر الفردي

يحسب | لكل طبيب ومجال ومنشأة، مع جزء نزاهة عام. تُعدّل النتائج بصعوبة الحالات حتى لا يُعاقب الطبيب الذي يعالج حالات أعقد.

المستوى	الوصف	زيادة إطلاق على الحماية	الإجراء
I0	ضمن المتوقع	0.0+ نقطة مئوية	لا تغيير
I1	تحت المراقبة	0.5+	تنبيه ومتابعة
I2	مرتفع	1.0+	احتجاز أشد وخطة تحسين
I3	مرتفع جداً/مخالفات متكررة	2.0+	مراجعة بشرية وقد تصل الزيادة إلى 3+ بقرار مسبب

مكوّن الخطر	الوزن الافتتاحي
الفشل المعدل بصعوبة الحالة	30%
المطالبات المدفوعة وحجم الخسارة	25%
إعادة العلاج/الإحالة الإلزامية	15%
الإفصاح الذاتي مقابل الاكتشاف المتأخر	10%
نقص التوثيق وإخفاء المضاعفات	10%
الدفع الخارجي ومخالفات النزاهة	10%

- لا تفرض الزيادة قبل حد أدنى من الأدلة أو دون مراجعة عند الأثر المالي الكبير.
- تُخفّض تدريجياً بعد فترتين أو ثلاث فترات مستقرة.
- تذهب الزيادة إلى صندوق الحماية، ولا تعد عمولة تشغيلية.
- ارتفاع | قد يغيّر ملف الاحتجاز حتى إذا لم يتغير الحرف العلمي فوراً.

19. الأطباء المؤسسون والاشتراكات والرسوم

البند	قاعدة الإطلاق
صفة الطبيب المؤسس	Flag/عضوية Cohort تمنحها الإدارة وفق سياسة إصدارية؛ لا يُثبت عدد 300 داخل الكود.
عمولة المنصة	إعفاء 100% حتى إشعار آخر؛ تنتهي للحجوزات الجديدة فقط عند تغيير السياسة.
مساهمة الحماية	تُدفع كاملة حسب H + I؛ لا تشملها منحة التأسيس.
رسوم الدفع	الإعفاء لا يشملها؛ يتحملها الطرف المحدد في السياسة العامة السارية.
الاشتراك الشهري	لا يعتمد جدولاً افتتاحياً جديداً في هذا المرجع؛ default=0 مع محرك تفعيل وإعفاء ديناميكي.
صياغة العرض	«إعفاء تأسيس من عمولة المنصة حتى إشعار آخر، وفق السياسة التجارية السارية».

20. التسعير المرجعي

- السعر المرجعي يُحسب لكل خدمة ومنطقة، ويتحدث وفق Policy Version.
- الموقع يؤثر في السعر والوصول، لا في S.
- يعرض السعر الكامل والمراحل والرسوم للمريض قبل الدفع.
- أي خدمة إضافية أو ترقية علاجية تحتاج موافقة ودفعاً داخل المنصة خلال 24 ساعة من قبولها.

الحساب	الغرض	قاعدة الحركة
أموال المرضى المعلقة	المبالغ قبل استحقاق الأطراف	لا تستخدم تشغيلياً.
مستحقات الطبيب المعلقة	Dn مقسم إلى شرائح	تُجمّد عند النزاع أو نقص التوثيق.
مستحقات الطبيب المتاحة	الشرائح المستوفية	تدخل التسوية الأسبوعية.
إيراد المنصة	Pc الفعلية بعد الإعفاءات	تدفع منها رسوم المنصة وضرائبها.
صندوق الحماية	Gb + Ra والمطالبات المؤهلة	منفصل؛ ليس إيراداً تشغيلياً.
احتياطي المنازل	مطالبــــــــــــــــــــات واســـــــــــــــــــــة chargebacks وترددات	لا يتحرر قبل الإغلاق.
المعلقات والأخطاء	Webhooks أو دفعات غير مطابقة	تسوية يدوية بمبدأ الشخصين.
رصيد طبيب سالب	استرداد بعد دفع الطبيب	مقاصة مستقبلية وفق العقد.

قاعدة محاسبية: جميع القيود append-only. لا حذف ولا كتابة فوق الأصل؛ كل تصحيح قيد عكسي مرتبط بالعملية والسبب والموافقات.

22. دورة المعاملة المالية

1. ينشئ الطبيب عرضاً أو مرحلة علاج من قاموس الخدمات.
2. يتحقق النظام من S وصلاحيه الخدمة والمنشأة، ثم يعرض خيارات P و H المسموحة.
3. يحسب السعر والعمولة والحماية و I والرسوم وجدول التحرير من السياسة الفعالة.
4. يعرض للمريض والطبيب الشروط، ثم تُنشأ FinancialTermsSnapshot عند القبول.
5. يدفع المريض؛ تسجل الأموال معلقة بمعرف فريد و idempotency key.
6. يُثبت الحضور والمرحلة، ويرفع الطبيب التوثيق الإلزامي خلال 24 ساعة مع مهلة تصحيح 48 ساعة.
7. يفحص الذكاء الاصطناعي الاكتمال والجودة، ويصعد الحالات المحددة إلى المراجع البشري.
8. تُخصص الدفعة إلى Pc و Gb و Ra و Dn، ثم يطبق ملف الاحتجاز.
9. تتحرر الشرائح عند استيفاء الزمن والمتابعة وعدم وجود نزاع، وتجمع في تسوية أسبوعية.
10. تُغلق المعاملة عند نهاية الحماية أو تنفيذ قرار النزاع، مع حفظ السجل كاملاً.

23. حالات المعاملة البرمجية

المجموعة	الحالات
العرض والدفع	DRAFT_QUOTE → OFFERED → PATIENT_ACCEPTED → PAYMENT_PENDING → PAID → FUNDS_PENDING
التنفيذ	APPOINTMENT_CONFIRMED → SERVICE_IN_PROGRESS EVIDENCE_PENDING → AI_REVIEW → HUMAN_REVIEW →
التخصيص	ELIGIBLE_FOR_ALLOCATION → ALLOCATED → HOLDING PARTIALLY_RELEASED → AVAILABLE_FOR_PAYOUT →
التسوية	PAYOUT_PENDING → SETTLED → CLOSED
الإلغاء/الاسترداد	CANCELLED، NO_SHOW، REFUND_PENDING، PARTIALLY_REFUNDED، FULLY_REFUNDED، REVERSED
النزاع والحماية	DISPUTED، CLAIM_OPEN، CLAIM_APPROVED/REJECTED، CLAIM_PAID
الاستثناءات	PAYMENT_FAILED، CHARGEBACK_OPEN/WON/LOST، OFF_PLATFORM_SUSPECTED، MANUAL_RECONCILIATION، SUSPENDED

كل انتقل الى يحمي: actor_id, timestamp, reason_code, policy_version, documents, previous_state, new_state, correlation_id.

24. تحرير مستحقات الطبيب

تطبق النسب التالية على Dn المتغير، لا على 85% ثابتة. وهي إعدادات إطلاق في SettlementPolicy وليست قواعد مضمنة في الكود.

S	R0	R1	R2	R3
A	100% أولى	90% 10+ يوم 30	75% 15+ 10% 6 شهر 3	60% 20+ 20% 6 شهر 3
B	100% أولى	85% 15+ يوم 30	70% 20+ 10% 6 شهر 3	55% 20+ 25% 6 شهر 3
C	100% أولى	80% 20+ يوم 30	65% 20+ 15% 6 شهر 3	50% 20+ 30% 6 شهر بشروط 3
D	90% 10+ يوم 7	75% 25+ يوم 30	55% 20+ 25% 6 مختار 3	غير مؤهل
F	70% 30+ يوم 30	60% 40+ يوم 30 لخدمات مختارة	غير مؤهل	غير مؤهل

- يتأثر الملف بـ S والخدمة و R و H و I والتوثيق والنزاع؛ لا يتبع P وحدها.
- الشكوى الفعالة أو نقص التوثيق يجمد الشرائح غير المحررة.
- تسوية الأطباء خارجياً أسبوعية، مع بقاء تاريخ الاستحقاق لكل شريحة.
- يمكن تشديد الاحتجاز عند ارتفاع I أو نقص احتياطي الصندوق، للحجوزات الجديدة فقط.

25. العلاجات الطويلة والترقيات

المرحلة النموذجية	نسبة إرشادية	شرط الاستحقاق
التشخيص واعتماد الخطة	10-20%	فحص، أدلة، بدائل، موافقة.
بدء العلاج/الجراحة	20-30%	توثيق التنفيذ والمواد/الزرعات.
مرحلة وسيطة	20-30%	معلم سريري معرف في بطاقة الخدمة.
التسليم/الإكمال	20-30%	توثيق ما بعد العلاج وتأكيده.
المتابعة النهائية	10-20%	زيارة أو نافذة متابعة محددة.

- لكل مرحلة دفع وقيد واستحقاق Snapshot فرعي مرتبط بالخطة الرئيسية.
- لا يُحصل كامل العلاج الطويل بوصفه خدمة مكتملة من اليوم الأول.
- أي ترقية تحتاج عرضاً جديداً وموافقة ودفعاً داخل التطبيق؛ لا تغطي الحماية مبلغاً خارج المنصة.
- التقويم غير مدعوم في MVP حتى لو أمكن إنشاء خطة طويلة عامة.

26. صندوق الحماية وكفاية الاحتياطي

- الصندوق منفصل محاسبياً عن إيرادات الشركة ومستحقات الأطباء وأموال المرضى.
- مساهمة المعاملة = $G \times [g(H) + r(I)]$.
- لا يُستخدم للرواتب أو التسويق، ولا يُوصف كتأمين أو ضمان نتيجة مطلق قبل التحقق القانوني.
- الفئة F غير مشمولة، مع بقاء حقوق عدم التنفيذ والخطأ المهني والحقوق القانونية.

نسبة الكفاية	الحالة	الإجراء للحجوزات الجديدة
$1.50 \leq$	أخضر	استمرار طبيعي.
$1.49 - 1.20$	أصفر	مراجعة المساهمات والحدود وتقييد R3.
$1.20 >$	أحمر	تعليق حماية جديدة عالية المخاطر أو تمويل الاحتياطي.

نسبة الكفاية = الأصول السائلة المخصصة للصندوق ÷ المطالبات المتوقعة خلال 12 شهراً. تُراجع شهرياً وتُدقق ربع سنوي.

27. المطالبات ومصدر التعويض

السبب	المسؤولية	مصدر التمويل الأول
عدم تنفيذ الخدمة	تنفيذية واضحة	استرداد أموال المريض كاملة؛ لا يحدها H.
خطأ تقني/مخالفة بروتوكول	على الطبيب غالباً	الأموال غير المحررة ثم رصيد الطبيب/المقاصة، ثم الصندوق عند الحاجة وفق السياسة.
سبب مختلط	مشتركة	تقسيم مسبب بين الطبيب والصندوق.
فشل بيولوجي بلا تقصير	منخفضة/معدومة للطبيب	صندوق الحماية ضمن H.
عدم التزام المريض	على المريض غالباً	لا تعويض تلقائي؛ تسوية حسن نية إن قُدرت.
أدلة غير كافية	غير محسومة	تجميد واستكمال ومراجعة.

سلم التمويل: غير المحرر في الحالة → رصيد الطبيب والمقاصة عند ثبوت مسؤوليته → صندوق الحماية للحالات المؤهلة → حسن نية استثنائي من ميزانية المنصة.

28. النجاح والمضاعفات والفشل

المستوى	الوصف	التعويض الإرشادي	حصة الطبيب
0	نتيجة سليمة أو تغير متوقع موثق	0%	100% من Dn
1	نقص بسيط قابل للتصحيح	10-25%	75-90% بعد التصحيح
2	فشل علمي مع مراقبة/إحالة دون ضرر فوري	25-50%	40-75%؛ يحدد السبب
3	إعادة علاج/إحالة إلزامية	50-75%	0-40%
4	إعادة كاملة/قلع/عدم تنفيذ/ضرر جسيم	حتى 100%	0% عند مسؤولية الطبيب

الجدول إطار قرار وليس تشخيصاً. يقدّر الذكاء الاصطناعي الشدة والسبب والثقة، وتراجع المرجعية الطبية الحالات المؤثرة. إذا أصبحت إعادة العلاج أو القلع إلزامية قد يصل الاسترداد إلى كامل المبلغ.

29. الإفصاح الطوعي عن الحالة

- الإبلاغ خلال 72 ساعة من اكتشاف المشكلة وقبل شكوى المريض أو اكتشاف المنصة.
- إبلاغ المريض ورفع الصور والأشعة والملاحظات وقبول خطة التصحيح/الإحالة/التعويض.
- يمكن استبعاد الحالة من الدرجة العلنية حتى 10% من الحالات المؤهلة في نافذة متحركة 90 يوماً.
- تبقى الحالة في سجل المخاطر وصندوق الحماية والتدقيق، ولا يسقط حق المريض.
- الحالة فوق السقف تدخل في المؤشر العام؛ وتجاوز 10% في دورتين يفتح مراجعة إجبارية.
- الإفصاح المبكر يقلل عقوبة السلوك مقارنة بالإخفاء، لكنه لا يمحو النتيجة الداخلية أو الالتزام المالي.

30. الإلغاء وعدم الحضور والاسترداد

الحالة	المريض	الطبيب	المنصة
< 24 ساعة	100%	0%	0%؛ الرسوم حسب السياسة
6-24 ساعة	90%	7%	3%
> 6 ساعات	75%	17%	8%
عدم حضور	60%	25%	15%
إلغاء الطبيب	100% + رصيد اختياري	0%	تسجل مخالفة
قوة قاهرة	100% أو إعادة جدولة	0%	قرار موثق

تطبق هذه النسب على دفعة الحجز/المعاينة لا على علاج لم يبدأ، وتُخزن في CancellationPolicy قابلة للإصدار. الاسترداد بعد التخصيص ينشئ قيوداً عكسية ولا يحذف القيد الأصلي.

31. حل النزاعات والتحكيم

1. تسوية داخلية: جمع الملف والمدفوعات والصور والأشعة وقرار أولي مسبب.
2. مراجعة طبية متخصصة عند وجود مسألة سريرية؛ لا يقرر موظف الخدمة أو محكم غير طبي هذه المسألة منفرداً.
3. اعتراض مستقل عن صاحب القرار الأول.
4. محكم محايد من قائمة معتمدة يختاره الطرفان؛ يمكن أن يكون شخصية اجتماعية/دينية/مهنية مؤهلة ومستقلة.
5. في النزاع الطبي، يستعين المحكم بخبير أسنان في المجال، ويصدر القرار خلال مهلة محددة.
6. تنفذ التسوية أو الاسترداد أو إعادة العلاج وفق القرار، مع بقاء الحقوق التي لا يسمح القانون بالتنازل عنها.

الحقول	ما يجب أن يحفظه النظام
النص، الإصدار، مربع مستقل غير محدد مسبقاً، الوقت، الحساب، الجهاز/السجل.	اتفاق حل النزاع
المعاملة، الادعاء، الأدلة، المبالغ المجمدة، المراجعين، تضارب المصالح.	ملف النزاع
السبب، المسؤولية، مبلغ/شكل التعويض، مصدر التمويل، مهل التنفيذ.	القرار
الطالب، الأدلة الجديدة، المراجع المستقل، النتيجة.	الاعتراض

قيد قانوني: لا تعتمد المنصة تنازلاً مطلقاً عن القضاء أو التعويض. تُصاغ آلية التحكيم وحدود المسؤولية بواسطة محام سوري «إلى أقصى حد يسمح به القانون»، ولا تُسقط حقوقاً غير قابلة للتنازل.

32. مكافحة الدفع خارج المنصة

المستوى	الإشارة/المخالفة	الإجراء
1	طلب دفع خارجي أو ترقية غير مسجلة	تجميد الشرائح، تنبيه، خفض النزاهة، طلب استيضاح.
2	دفع خارجي مثبت	لا حماية للجزء الخارجي، مقاصة/غرامة وفق العقد، رفع ومراجعة التصنيف.
3	تكرار	تجميد أوسع، تعليق حجوزات، خفض فئة بعد مراجعة.
4	نمط منظم/تزوير	حجز أرصدة وفق القانون، فصل، سبب حيادي، إحالة قانونية.

- اتصالات عشوائية بالمرضى وموظف نزاهة مستقل.
- مكافأة محدودة للمريض الذي يقدم دليلاً صحيحاً من ميزانية التسويق، لا من الصندوق.
- ربط كل خدمة إضافية بدفع داخل المنصة خلال 24 ساعة.
- الإشارة الآلية لا تساوي إدانة؛ العقوبة بعد تدقيق وتناسب وحق اعتراض.

الجزء الثالث

متطلبات التصميم والبرمجة والحوكمة

33. نقطة الشروط لكل معاملة

المجموعة	الحقول التي لا يجوز إعادة قراءتها من الإعدادات الحية
الهوية	transaction_id، plan_id، stage_id، doctor_id، domain_id، facility_id، service_id.
التصنيف	S، نقاط S، K، EU، reason codes، grade_snapshot_id.
التجارة	P، نطاق السعر، السعر، subscription treatment، founding exemption.
الحماية	H، g(H)، cap(H)، l، r(I)، مدة الحماية.
الرسوم	c(P)، gateway_fee_payer، الرسوم، الضرائب/الاستقطاعات.
التسوية	settlement_profile_id، الشرائح والتواريخ وشروط التحرير.
السياسات	policy_version، service_version، model_version، cancellation/refund/dispute versions.
القبول	نسخة الشروط، موافقة الطبيب والمريض، الوقت، القناة، سجل الجهاز.

عدم الأثر الرجعي: لا تتغير معاملة مدفوعة عند تعديل النسب أو التصنيف أو السياسة. الاستثناء الوحيد هو قيد تصحيح مسبب وموثق بسبب احتيال أو خطر سلامة أو التزام قانوني، دون محو الأصل.

34. محرك السياسات الديناميكية

حالة الإصدار	المعنى
DRAFT	قيد الإعداد ولا يؤثر في المعاملات.
APPROVED	وافق عليه المالك والمدير التنفيذي؛ غير ساري بعد.
SCHEDULED	له تاريخ سريان مستقبلي.
ACTIVE	يطبق على المعاملات الجديدة.
RETIRED	متوقف مع بقاءه مرجعاً للمعاملات القديمة.

الإعدادات القابلة للتعديل	أمثلة
التصنيف	الأوزان، الحدود، K/EU، بوابات الأجهزة، الخدمات لكل فئة، المراجعة.

الإعدادات القابلة للتعديل	أمثلة
التجارة	العمولات، الاشتراكات، الإعفاءات، نطاقات الأسعار، تواريخ السريان.
الحماية	المساهمات، السقوف، ، الاحتياطي، مدة التغطية، الخدمات الموقوفة.
التسوية	ملفات الاحتجاز، دورة الدفع، الرصيد السالب، حدود الموافقة.
الاسترداد	الإلغاء، عدم الحضور، chargeback، صلاحيات الموظفين.
المراجعات	مدة الاتصال الإلزامي، عينات التحقق، قواعد النشر والاعتراض.

- كل تعديل يحتاج سبباً، أثراً متوقعاً، منشئاً، مراجعين، موافقة مزدوجة، وتاريخ سريان.
- لا يحتاج الطبيب إلى توقيع عقد جديد لكل تغيير مستقبلي، لكن يجب أن يرى الشروط السارية قبل قبول أول حجز جديد، ويُحفظ إقراره.
- يستطيع الطبيب رفض السياسة بوقف الحجوزات الجديدة أو إنهاء العضوية، دون المساس بالخطط السابقة.
- تعديلات المعايير السريرية تحتاج مراجعة طبية موثقة قبل موافقة المالك والمدير التنفيذي.

35. الأدوار والصلاحيات

الدور	الصلاحيات الأساسية	قيود الفصل
الطبيب	رفع البيانات والحالات، اختيار P/H، قبول الحجوزات، الإفصاح، الاعتراض.	لا يتحقق من نفسه ولا يعدل القيود.
المريض	الحجز والدفع والموافقة والتقييم والشكوى.	لا يرى سجلات مرضى آخرين أو مؤشرات سرية.
موظف التحقق	فحص مؤهلات/اتصال مراجعات.	لا يغير تصنيفاً أو قراراً مالياً منفرداً.
المراجع الطبي	حالات وفشل واعتراضات المجال.	تعارض مصالح وتصريح استقلال.
المالية	مطابقة وتسوية وقيود واسترداد ضمن حدود.	مبدأ الشخصين للتحويل والصندوق.
إدارة النزاهة	تحقيق تقييمات وتحايل ودفع خارجي.	الإشارة الآلية ليست إدانة.
مدير النظام	تكوين تقني ومستخدمون.	لا يعتمد سياسة تجارية/سريية منفرداً.
المالك + المدير التنفيذي	اعتماد السياسات التجارية والتشغيلية.	التغيير إصدارياً وبسجل؛ السري بعد مراجعة مختصة.

36. نموذج البيانات الأساسي

الكيان	الحقول/العلاقات الحرجة
DoctorProfile	الهوية، الترخيص، الحالة، الفروع، الأدوار، founding cohort.
Facility	الموقع، الأشعة، السلامة، الاعتماد، الوثائق والإصدارات.
DomainPrivilege	doctor × domain × facility، الخدمات، القيود، البداية والانتها.
ScientificGrade	S، K، EU، final grade، reasons، status، valid_from/to.
CommercialChoice	P و H لكل مجال، تاريخ السريان، مصدر التغيير.
ServiceDefinition	المجال، R، الأهلية، الأدلة، المتابعة، المال، version.
ClinicalCase	الخطأ، الخطر، الأدلة، النتيجة، المتابعة، الحوادث.
PatientReview	transaction، الأبعاد، النص، appeal، status، call، OTP.
RiskProfile	doctor/domain/facility، I، المكونات، الزيادة، validity.
PolicyVersion	التصنيف والتجارة والحماية والتسوية والإلغاء والتوقعات.
GradeSnapshot	نسخة غير قابلة للتعديل من القرار وأسبابه.
FinancialTermsSnapshot	P/H/I والنسب والسعر والرسوم والاحتجاز والقبول.
TreatmentPlan/Stage	الخدمات والمراحل والمدفوعات والتوثيق.
Payment/LedgerEntry	مراجع idempotent وقيود append-only.
Claim/Dispute/Appeal	الأدلة والمراجعين والقرار والمصدر المالي.

37. متطلبات واجهة المريض

الشاشة/المكون	المطلوب
بطاقة الطبيب	المجال، H، P، S، وسقفها، R، الثقة، الحالات، آخر تحديث، المسافة، التوافر.
الفلتر	المجال، H، P، S، النجوم، السعر، المنطقة، الموعد، الوصول.
صفحة الطبيب	تفصيل الفروع والمجالات؛ لا تعميم رتبة مجال على آخر.
خطة العلاج	الخدمات والمراحل والسعر والرسوم والحماية والإلغاء والتوثيق المتوقع.
الدفع	الإجمالي النهائي والنسخ المقبولة؛ بلا رسوم مخفية.
المتابعة	المواعيد، المراحل، الحماية المتبقية، رفع شكوى/تقييم.

الشاشة/المكون	المطلوب
التقييم	OTP وحالة قيد التحقق وخصوصية رقم الهاتف.
النزاع	الخطوات والمهل والأدلة والحالة والقرار.

قاعدة العرض: لا تستخدم «أفضل طبيب»، «طبيب مضمون»، «ضعيف» أو «فاشل». يظهر أن التصنيف خاص بالمجال والمنشأة وفترة القياس، وأن الحماية مشروطة وليست ضمان نتيجة.

38. متطلبات لوحة الطبيب

الوحدة	ما يراه	الإجراءات
ملخص المجالات	S و K/EU وحالة كل فرع	فتح التفاصيل والسبب.
الفئة التجارية	P و H والعمولة والمساهمة والنطاق	اختيار مسموح للحجوزات الجديدة.
الخدمات	الأهلية والتجهيز والتوثيق	طلب تفعيل/استكمال.
الحالات	المراحل ونواقص الأدلة والمتابعة	رفع/تصحيح دون حذف الأصل.
النتائج والمضاعفات	اتجاهات ومهلة 72 ساعة	إفصاح وخطة تصحيح.
المراجعات	تقييمات منشورة/معلقة	رد مهني واعتراض.
المخاطر	أسباب وآثاره دون كشف خوارزمية الاحتيال	خطة تحسين.
المالية	معلق/متاح/محول/سالب، الشرائح، المطالبات	مطابقة وتنزيل كشف.
السياسات	الإصدار الساري والقادم	إقرار أو وقف حجوزات جديدة.

39. متطلبات لوحة الإدارة

المجال الإداري	الوظائف
الأطباء والمنشآت	تحقق، صلاحيات، فروع، أجهزة، تعليق، سجل.
المجالات والخدمات	قاموس، R، أدلة، متابعة، أهلية، إصدار.
التصنيف	S/K/EU، أسباب، مراجعات، معايير، نشر، اعتراض.
التجارة والحماية	P/H، عمولات، مساهمات، سقف، founding cohorts، I.
السياسات	Draft/Approve/Schedule/Activate/Retire ومقارنة الإصدارات.
المدفوعات	المعاملات، الدفتر، المعلقات، التسويات، الاسترداد، chargeback.

المجال الإداري	الوظائف
صندوق الحماية	الرصيد والكفافية والمطالبات والتنبؤات والقيود.
المراجعات	OTP، الاتصالات، الاشتباه، النشر، الاعتراض.
النزاعات	تعيين مراجع/محكم، الأدلة، التجميد، القرار، التنفيذ.
النزاهة	الدفع الخارجي، الصور المكررة، العلاقات والأنماط.
التقارير	KPI، exports، audit log، health checks.

40. التواصل العلمي المباشر

- تظهر وسيلة مراسلة Professor Sam Wise للأطباء المصنفين A إلى D فقط، وفق إعداد الإدارة.
- القناة رسائل WhatsApp فقط؛ لا مكالمات غير مجدولة.
- لا تظهر لل فئة F إلا باستثناء إداري موثق.
- تُسجل القرارات العلمية المؤثرة داخل UberTib أو تُلخص في سجل رسمي؛ لا تصبح المحادثة الخارجية مصدراً وحيداً غير قابل للتدقيق.

41. الخصوصية والأمان

المبدأ	المتطلب
تقليل البيانات	جمع ما يلزم للتوثيق والتقييم والدفع والنزاع فقط.
الموافقة	موافقات منفصلة للصور والأشعة والتحليل والتحسين وإزالة الهوية.
الهوية	رقم المريض سري؛ لا يسلم للطبيب لأغراض مراجعة التقييم.
الوصول	RBAC، أقل صلاحية، MFA للإدارة، فصل البيئة.
السجل	تدقيق للقراءة والتعديل والتنزيل والقرار.
الحفظ	مدد حسب نوع السجل والقانون والنزاع؛ سياسة حذف/إخفاء هوية.
التشفير	في النقل والتخزين، مع إدارة أسرار ومفاتيح.
الذكاء الاصطناعي	نسخ نموذج ومدخلات وأسباب، تقييم تحيز وأداء وانحراف.
الدفع	لا كلمات مرور محافظ ولا بيانات بطاقات حساسة داخل المنصة.

42. متطلبات بوابة الدفع والتكامل

- حساب تجاري رسمي و KYC/KYB للمنصة والطبيب حسب مزود الدفع.

- API للدفع والاسترداد الجزئي والكامل والتحويل والتقارير.
- Webhooks موقعة، إعادة أمانة، correlation IDs، idempotency.
- مرجع لكل خطوة ومرحلة ودفعة وتحويل واسترداد ومطالبة.
- حسابات فرعية إن توفرت؛ وإلا دفتر أستاذ داخلي وتسوية موثقة.
- دعم المقاصة والرصيد السالب وعكس التحويل حيث يسمح المزود.
- مزود ثانٍ قابل للتبديل دون تغيير منطق الدفتر.
- لا يبدأ التحصيل المركزي أو الاحتجاز قبل رأي قانوني وعقد مزود مرخص.

43. التقارير ومؤشرات الأداء

التقرير	الدورية	المحتوى
مطابقة المدفوعات	يومي	المقبوضات، Webhooks، الفروقات، المعلقات.
تسوية الأطباء	أسبوعي	المتاح، المحتجز، المحول، الرصيد السالب.
صندوق الحماية	شهري	الرصيد، المساهمات، المطالبات، الكفاية، loss ratio.
التصنيف	كل 90 يوماً	S/K/EU والحركات والاعتراضات حسب مجال وفرع.
S/P/H	شهري	الفرق بين العلمي والسعري والحماية وأثره المالي.
المخاطر	شهري	I والزيادات والتحسين والفشل المعدل.
المراجعات	شهري	المعلق والمنشور والمرفوض والاتصالات والاعتراضات.
النزاعات	شهري	السبب والمدة والمبلغ والمصدر ونتيجة الاعتراض.
الإعفاءات	شهري	تكلفة الأطباء المؤسسين وانتهاء/بدء الإعفاء.
إصدارات السياسة	عند كل تغيير	الأثر المتوقع والفعلية وعدد المعاملات تحت كل إصدار.

الجزء الرابع

معايير القبول والإطلاق والمرجع التقني

44. معايير القبول الوظيفية

ID	السيناريو	النتيجة المقبولة
AC-01	طبيب S=A يختار P=C و H=A	عمولة 7% وحماية 5% قبل ا؛ يظهر A/C/A وسقف 100%.
AC-02	الطبيب نفسه يختار H=C	عمولة 7% وحماية 2%؛ يظهر سقف 50%.
AC-03	طبيب يحاول P أعلى من S	رفض مع شرح الخيارات المسموحة.
AC-04	طبيب يحاول اختيار F طوعاً	رفض؛ F ليست فئة تجارية اختيارية.
AC-05	فرع بأشعة تقليدية	سقف S النهائي D في ذلك الفرع.
AC-06	فرع بلا أشعة ذروية	F في ذلك الفرع وفق السياسة، مع عدم تعميمه على فرع آخر.
AC-07	أدلة C0	لا حرف علني؛ «قيد التقييم» وخدمات محدودة بسياسة تأهيل.
AC-08	تغيير نسب السياسة بعد الدفع	لا تتغير المعاملة القديمة؛ الجديدة تأخذ الإصدار الجديد.
AC-09	طبيب مؤسس H=A	Pc=0، وتبقى Gb و Ra والرسوم حسب السياسة.
AC-10	ا يرتفع من I0 إلى I2	تضاف نقطة مئوية للحماية على المعاملات الجديدة ويُحفظ السبب.
AC-11	تقييم بلا حجز/دفع	رفض قبل OTP والنشر.
AC-12	تقييم سلبي حقيقي	ينشر بعد التحقق؛ لا يحذف لمجرد السلبية.
AC-13	ادعاء طبي في المراجعة	CLINICAL_ESCALATION؛ لا يحسمه موظف الاتصال.
AC-14	تعويض <10% أو قلع/إعادة علاج	مراجعة بشرية إلزامية.
AC-15	إفصاح خلال 72 ساعة ضمن سقف 10%	يُستبعد علنياً فقط ويبقى داخلياً ومالياً.
AC-16	شكوى مفتوحة قبل شريحة	تجميد جميع الشرائح غير المحررة.
AC-17	خدمة تقويم في MVP	غير ظاهرة وغير قابلة للحجز.
AC-18	Webhook مكرر	عملية واحدة فقط بفضل idempotency.
AC-19	استرداد بعد تسوية الطبيب	قيد عكسي ورصيد سالب/مقاصة؛ لا حذف.
AC-20	عدم توازن الدفتر مع المزود	MANUAL_RECONCILIATION ومنع إغلاق اليوم فوق حد التسامح.

45. خطة التنفيذ والإطلاق

المرحلة	المخرجات	بوابة الانتقال
0 - تثبيت القواميس	المجالات الأربعة، الخدمات، R، التوثيق، المتابعة، المعادلات.	اعتماد أكاديمي وإداري.
1 - البنية الأساسية	الملفات والفروع والتصنيف والسياسات واللقطات والدفتر.	اختبارات وحدات وقواعد قبول.
2 - التكامل المالي	الدفع، Webhooks، الاسترداد، التسوية، الصندوق.	رأي قانوني وعقد مزود.
3 - واجهات المستخدم	المريض والطبيب والإدارة والفلاتر والإفصاح.	اختبارات UX وشفافية الأسعار.
4 - المعايير الحية	تشغيل تجاري 90 يوماً وتصنيفات أولية ومراجعات بشرية موسعة.	بيانات كافية ومراقبة أخطاء.
5 - الاعتماد المستقر	نشر دوري وربط مالي كامل ومعامل مخاطر.	مراجعة نتائج المعايير والاحتياطي.
6 - التوسع	مدن وخدمات جديدة؛ التقويم كمال مستقل إن اعتمد.	سياسة ومعايير وضمان خاصة.

46. بوابات ما قبل الإنتاج

البوابة	المطلوب قبل التفعيل
طبية	تعريفات النجاح والفشل والمضاعفات، متطلبات كل خدمة، قاعدة الأشعة، المتابعة، حدود R.
قانونية	التحصيل والاحتجاز والصندوق، الشروط، الخصوصية، التحكيم، حدود المسؤولية.
مالية	متحمل رسوم الدفع، الاشتراك، الاحتياطي، النسب، الضرائب، المطابقة.
تقنية	أمن، idempotency، audit، backup، disaster recovery، أداء وavailability.
ذكاء اصطناعي	اختبار جودة وتحيز، تفسير، human-in-the-loop، monitoring، fallback.
تشغيلية	موظفو التحقق والنزاع والنزاهة، SLA، التدريب، إجراءات الطوارئ.

47. توجيهات نهائية لفريق التصميم والبرمجة

- لا تستخدم أي جدول قديم يتضمن E أو صافي طبيب ثابتاً 85%.
- لا تخط P و H و R؛ كل منها مستقل في قاعدة البيانات والواجهة.
- لا تكتب النسب أو الحدود أو الإعفاءات داخل الكود؛ تُقرأ من Policy Version.
- لا تعيد حساب معاملة قديمة من الإعدادات الحية؛ استخدم Snapshot.
- لا تجعل الذكاء الاصطناعي صاحب قرار نهائي في المسائل الجوهرية.

- لا تنشر مراجعة قبل تحقق المعاملة و OTP والمسار البشري المطلوب.
- لا تسمح بإجراء غير متوافق مع المجال والمنشأة وبطاقة الخدمة حتى لو كانت الدرجة مرتفعة.
- لا تستخدم F بدلاً من تعليق الترخيص أو التحقيق في التزوير والسلامة.
- لا تعتبر صندوق الحماية إيراداً، ولا تسمه تأميناً أو ضمان نتيجة دون رأي قانوني.
- كل إجراء مالي أو سريري أو تصنيفي مهم يجب أن يكون قابلاً للتفسير والتدقيق والاسترجاع.

قاعدة التسليم: يُعد أي تنفيذ غير قادر على إعادة إنتاج سبب التصنيف وشروط المعاملة ونسخة السياسة تنفيذاً غير مطابق، حتى لو كانت واجهاته سليمة بصرياً.

الملحق أ - مصفوفة الإعدادات الافتراضية

الإعداد	القيمة الافتتاحية	قابلية التعديل
الفئات العلمية	A/B/C/D/F	إصدار تصنيف؛ حذف E نهائي.
الدورة	90 يوماً	نعم مع ضوابط طبية.
المعايرة الحية	90 يوماً	نعم.
الإفصاح	72 ساعة	نعم.
سقف الاستبعاد	10% / نافذة 90 يوماً	نعم بعد مراجعة طبية/أخلاقية.
عمولات P	4/5/7/8.5/10%	نعم للحجوزات الجديدة.
مساهمات H	0/1/2/3.5/5%	نعم.
سقف H	0/30/50/70/100%	نعم.
I	pp 2+/1+/0.5+/0	نعم؛ 3+ استثنائي مسبب.
اشتراك	0 عند الإطلاق	قابل للتفعيل.
رسوم البوابة	PLATFORM مؤقتاً حتى قرار إطلاق	نعم، وتثبت في Snapshot.
m للمراجعات	20	نعم بعد المعايرة.
كفاية الصندوق	أخضر 1.50، أصفر 1.20، أحمر أقل	نعم وفق إدارة مخاطر.

الملحق ب - المصطلحات

المصطلح	التعريف التشغيلي
S	التصنيف العلمي المستحق في مجال ومنشأة محددين.
P	الفئة السعرية التي يختارها الطبيب مساوية أو أدنى من S.
H	مستوى الحماية الذي يحدد المساهمة والسقف.
R الاجتماعي	تجربة المرضى الموثقة بالنجوم؛ لا تدخل في S.
I	مخاطر فردية معدلة تؤثر في مساهمة الحماية والاحتجاز.
K/EU	ثقة الأدلة ووحداتها؛ تحدان السقف الممكن للتصنيف.
R0–R3	مجموعات مخاطر الخدمات المالية والسريية.
قيد التقييم	طبيب مرخص قليل الأدلة؛ ليست فئة E أو F.
Snapshot	نسخة ثابتة من القرار والشروط وقت المعاملة.
Policy Version	حزمة إعدادات لها حالة وإصدار وتاريخ سريان.
صندوق الحماية	رصيد مخصص للمطالبات المؤهلة؛ ليس إيراداً ولا تأميناً تلقائياً.
التعليق	وقف حساب/مجال بسبب ترخيص أو سلامة أو نزاهة؛ ليس رتبة منخفضة.

نهاية الوثيقة — الإصدار المرجعي 2.0